DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

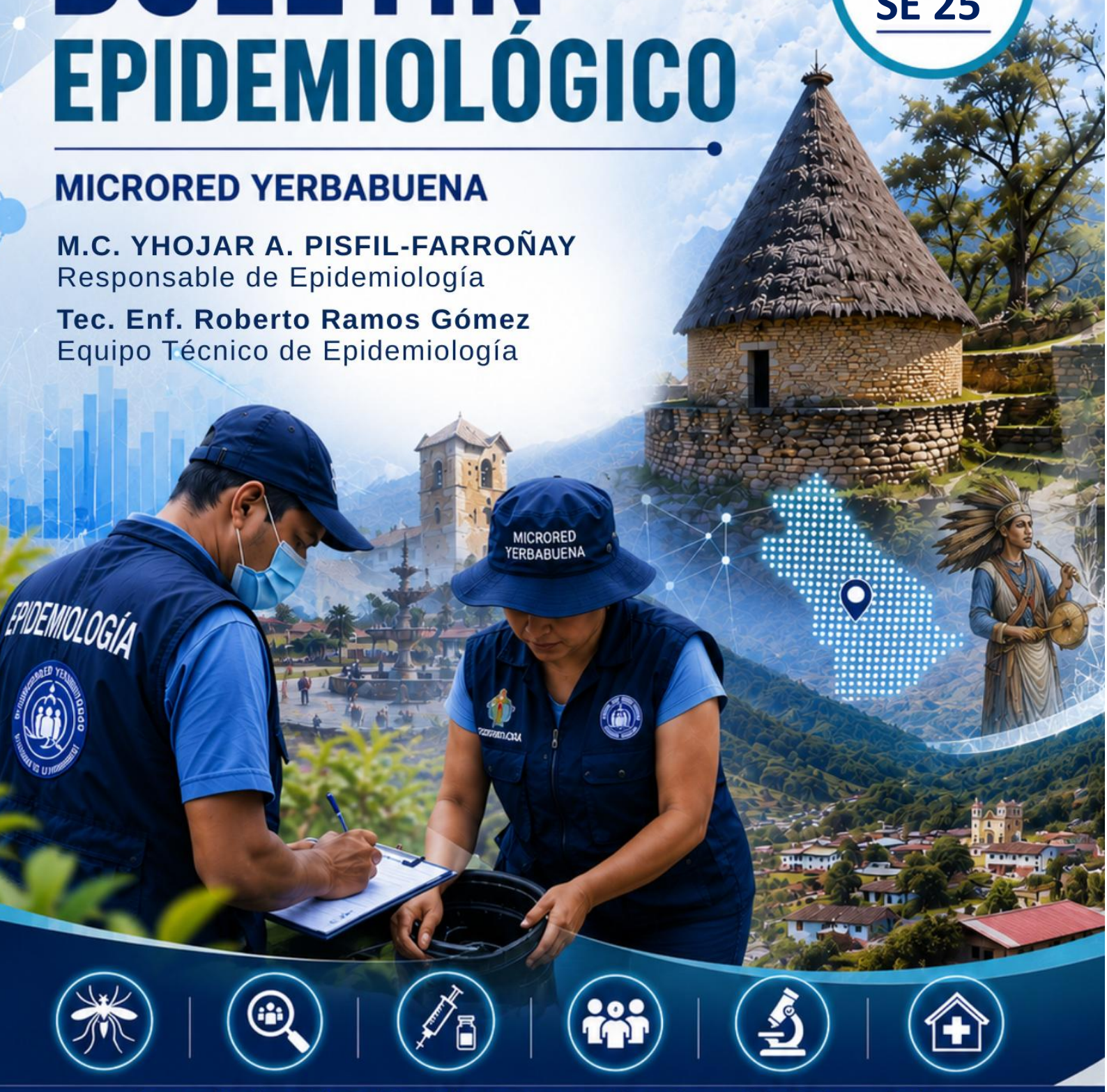
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SE 25

MICRORED YERBABUENA

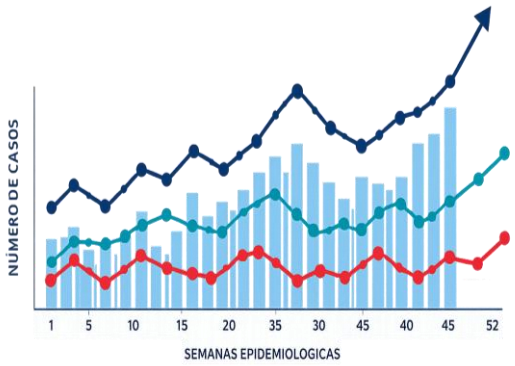
M.C. YHOJAR A. PISFIL-FARROÑAY
Responsable de Epidemiología

Tec. Enf. Roberto Ramos Gómez
Equipo Técnico de Epidemiología



Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

PRESENTACIÓN



La Oficina de Epidemiología de la Microred de Salud Yerbabuena pone a disposición el presente Boletín Epidemiológico, publicación técnica elaborada de manera periódica con el propósito de difundir el análisis de la situación epidemiológica de los principales eventos sujetos a vigilancia en salud pública dentro de su jurisdicción.

La información presentada en este boletín proviene de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), mediante la notificación semanal realizada por los establecimientos de salud que conforman la Microred de Salud Yerbabuena, complementada con información obtenida de los sistemas oficiales de vigilancia epidemiológica, investigaciones epidemiológicas de campo, vigilancia basada en eventos, salas situacionales y otras actividades desarrolladas por la Oficina de Epidemiología.

La Microred de Salud Yerbabuena, perteneciente a la Red Integrada de Salud Chachapoyas, desarrolla actividades permanentes de vigilancia epidemiológica en los distritos de La Jalca, Mariscal Castilla, San Juan de Lopecancha y un anexo del distrito de Santo Tomas, comprendiendo establecimientos de salud ubicados en zonas rurales donde el monitoreo continuo de enfermedades transmisibles, enfermedades metaxénicas, zoonosis, enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades no transmisibles y otros eventos de importancia en salud pública constituye una herramienta fundamental para la protección de la salud de la población.

El presente boletín tiene como finalidad proporcionar información epidemiológica actualizada mediante el análisis de tendencias, distribución de casos, comportamiento de los principales daños sujetos a vigilancia e indicadores epidemiológicos, contribuyendo a la detección temprana de brotes, la identificación de riesgos y la implementación de intervenciones oportunas para la prevención y control de enfermedades.

La difusión periódica de este documento busca fortalecer el uso de la información epidemiológica como soporte para la toma de decisiones, la planificación sanitaria y la mejora continua de las acciones de vigilancia, prevención y respuesta frente a eventos que representen un riesgo para la salud pública en el ámbito de la Microred de Salud Yerbabuena.



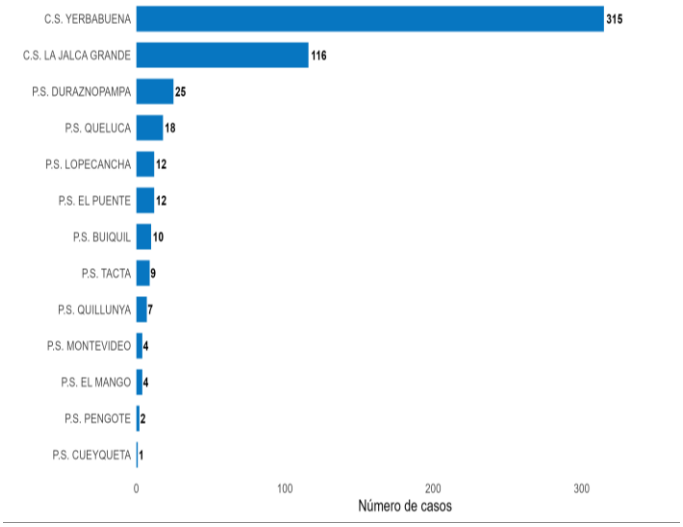
M.C. Yhojar A. Pisfil-Farroñay
Responsable de Epidemiología
Microred Yerbabuena

Situación epidemiológica de Leishmaniasis

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria desatendida causada por protozoarios del género *Leishmania*, transmitidos al ser humano mediante la picadura de flebótomos hembras infectados de los géneros *Lutzomyia* (Américas) y *Phlebotomus* (Viejo Mundo). La enfermedad presenta tres formas clínicas principales: cutánea, mucosa y visceral, siendo la forma cutánea la de mayor frecuencia en el continente americano y la predominante en el Perú[1].

En las Américas, la leishmaniasis constituye un importante problema de salud pública debido a su amplia distribución geográfica, su asociación con poblaciones rurales y vulnerables, y el impacto que ocasiona por las lesiones cutáneas permanentes, las secuelas funcionales y la discapacidad derivada de las formas mucosas. En el Perú, la leishmaniasis es una enfermedad endémica presente en diversas regiones de la Amazonía y de la vertiente oriental de los Andes. En la región Amazonas, la transmisión se mantiene principalmente en localidades rurales donde confluyen condiciones ecológicas favorables para el vector y reservorios naturales [3].

Gráfico 01. Microred Yerbabuena: Casos acumulados históricos de leishmaniasis, según establecimientos de salud, 2010 – 2026 (SE25).



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

La distribución histórica de los casos de leishmaniasis registrados entre 2010 y el 2026 (S.E. 25) evidencia una marcada concentración de la enfermedad en el C.S. Yerbabuena, que acumula 315 casos, seguido del C.S. Jalca Grande con 116 casos. Ambos establecimientos concentran la mayor carga histórica de casos notificados dentro de la jurisdicción de la Microred de Salud Yerbabuena. En menor magnitud se encuentran el P.S. Duraznopampa (25 casos), P.S. Queluca (18 casos), P.S. Lopecancha (12 casos) y P.S. El Puente (12 casos), mientras que establecimientos como P.S. Cueyqueta, P.S. Pengote, P.S. El Mango y P.S. Montevideo presentan una menor frecuencia acumulada de casos durante el periodo evaluado. La distribución observada sugiere la existencia de focos históricos de transmisión en el ámbito de influencia de los establecimientos con mayor carga acumulada, lo que refleja la persistencia de condiciones ecológicas y ambientales favorables para la transmisión de la enfermedad.

Tabla 01. Microred Yerbabuena: Número de casos por tipo de leishmaniasis y defunciones 2021* – 2026*.

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	17	21	24	18	16	17
IA x 100 Mil Hab.	431.91	369.07	407.75	308.54	275.43	293.76
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POB	3936	5690	5886	5834	5809	5787

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

Hasta la S.E. 25 (2026) se notificaron 17 casos de leishmaniasis en la Microred de Salud Yerbabuena, alcanzando una incidencia acumulada de 293,76 casos por 100 000 habitantes. En comparación con el mismo periodo del año 2025, se registra un ligero incremento de un caso (16 vs. 17); sin embargo, la incidencia continúa siendo inferior a la observada entre los años 2021 y 2023. Durante el periodo analizado no se notificaron defunciones, manteniéndose una letalidad de 0%. El comportamiento epidemiológico observado evidencia una relativa estabilidad en la ocurrencia de casos durante los últimos años, por lo que resulta indispensable mantener las actividades de vigilancia, diagnóstico oportuno y control vectorial en las localidades con transmisión activa e histórica.

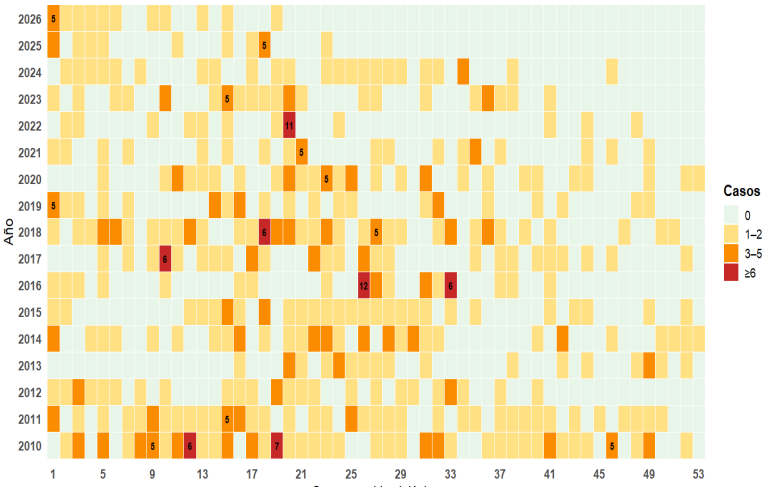
Tabla 02. Microred Yerbabuena: Distribución de los casos acumulados de leishmaniasis según variables epidemiológicas, 2010 – 2026(S.E. 25).

VARIABLE	CASOS	%	% ACUMULADO
GENERO			
F	220	53.40	53.40
M	192	46.60	100.00
ESTABLECIMIENTO			
C.S. YERBABUENA	282	68.45	68.45
C.S. LA JALCA GRANDE	48	11.65	80.10
P.S. DURAZNOPAMPA	23	5.58	85.68
P.S. QUELUCA	18	4.37	90.05
P.S. EL PUENTE	12	2.91	92.96
P.S. LOPECANCHA	11	2.67	95.63
P.S. BUIQUIL	5	1.21	96.84
P.S. EL MANGO	4	0.97	97.81
P.S. QUILLUNYA	3	0.73	98.54
P.S. TACTA	3	0.73	99.27
P.S. CUEYQUETA	1	0.24	99.51
P.S. MONTEVIDEO	1	0.24	99.75
P.S. PENGOTE	1	0.24	99.99
CURSO DE VIDA			
Niño [0-11]	152	36.89	36.89
Adulto [30-59]	110	26.70	63.59
Adolescente [12-17]	60	14.56	78.15
Joven [18-29]	48	11.65	89.80
Adulto Mayor [60+]	42	10.19	99.99
TIPO DIAGNOSTICO			
C	412	100.00	100.00
CASOS POR AÑO			
2010	50	12.14	12.14
2018	43	10.44	22.58
2011	37	8.98	31.56
2014	26	6.31	37.87
2012	25	6.07	43.94
2017	25	6.07	50.01
2020	25	6.07	56.08
2019	24	5.83	61.91
2023	24	5.83	67.74
2015	21	5.10	72.84
2022	21	5.10	77.94
2024	19	4.61	82.55
2026	17	4.13	86.68
2021	16	3.88	90.56
2025	16	3.88	94.44
2013	14	3.40	97.84
2016	9	2.18	100.02

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

La distribución de los casos acumulados evidencia un comportamiento epidemiológico particular, caracterizado por un predominio del sexo femenino (53,4 %), hallazgo que difiere de la mayoría de series publicadas en el Perú y otros países de América Latina, donde suele describirse una mayor frecuencia en varones debido a la exposición ocupacional en áreas boscosas[3]. Asimismo, los niños de 0 a 11 años concentraron el 36,9 % de los casos, constituyendo el grupo etario más afectado, lo que sugiere un patrón de transmisión con importante exposición en el entorno domiciliario o peridomiciliario. Finalmente, la totalidad de los casos registrados correspondió a la forma cutánea, manteniendo el perfil clínico predominante descrito para la región Amazonas y otras zonas endémicas del país.

Gráfico 02. Microred Yerbabuena: Comportamiento temporal de los casos de leishmaniasis cutánea según semana epidemiológica, 2010 - 2026*



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

El mapa de calor evidencia una transmisión endémica de leishmaniasis cutánea con marcada heterogeneidad temporal, caracterizada por fluctuaciones interanuales en la intensidad de notificación y ausencia de un patrón estacional definido. La ocurrencia de conglomerados de casos en semanas epidemiológicas específicas, sin repetirse de manera uniforme entre años, sugiere que la dinámica de transmisión responde a factores ecológicos y epidemiológicos locales más que a un comportamiento estacional recurrente. Asimismo, la mayor frecuencia de semanas con ausencia de casos o con baja intensidad de transmisión durante los años recientes indica una reducción en la agregación temporal de casos, aunque persiste la circulación de la enfermedad dentro del ámbito de la Microred.

Situación epidemiológica de Varicela

La varicela es una enfermedad exantemática aguda causada por el virus varicela-zóster (VZV), un alfaherpesvirus altamente transmisible que se propaga principalmente por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las lesiones vesiculares. Su período de incubación oscila entre 10 y 21 días (promedio de 14–16 días), mientras que la transmisibilidad inicia 1 a 2 días antes del exantema y se mantiene hasta que todas las lesiones evolucionan a costras. Aunque generalmente presenta un curso autolimitado, puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en lactantes, adultos, gestantes e individuos inmunocomprometidos [4,5].

En el Perú, la varicela es un evento sujeto a vigilancia epidemiológica y constituye una enfermedad inmunoprevenible desde la incorporación de la vacuna contra la varicela al Esquema Nacional de Vacunación en el 2018. La vacunación ha demostrado una reducción significativa en la incidencia, hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la enfermedad; sin embargo, la vigilancia epidemiológica continúa siendo esencial para detectar oportunamente brotes, monitorear el impacto del programa de inmunización e identificar cambios en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad[6,7].

Tabla 03. Microred Yerbabuena: Número de casos por tipo de varicela y defunciones. 2021 - 2026*

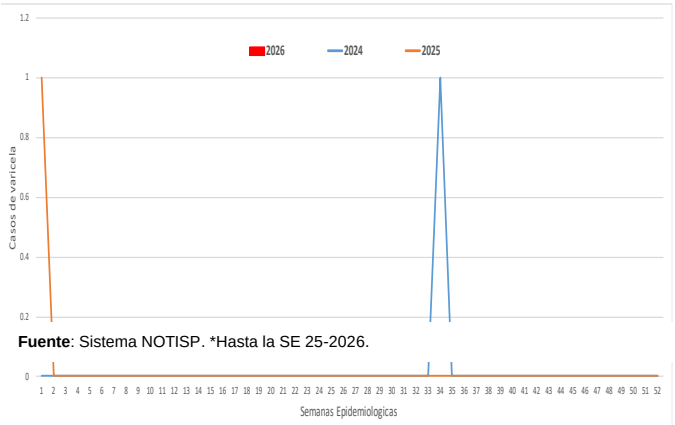
AÑOS	2021	2022	2023	2024	2025	2026
N° de Casos	0	0	4	0	1	0
IA x 100 Mil Hab.	0.00	0.00	67.96	0.00	17.21	0.00
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POB	3936	5690	5886	5834	5809	5787

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

En la tabla 03, entre los años 2021 y la Semana Epidemiológica 25 del 2026, la varicela mantuvo un comportamiento esporádico en la Microred de Salud Yerbabuena, registrándose casos únicamente durante los años 2023 y 2025. El mayor número de casos se notificó en 2023, alcanzando una incidencia acumulada de 67,96 por 100 000 habitantes, mientras que en 2026 no se han registrado casos. Durante todo el periodo evaluado no se notificaron defunciones, manteniéndose una letalidad de 0 %, lo que evidencia la ausencia de formas graves y de transmisión sostenida en la jurisdicción.

El comportamiento temporal de la varicela (gráfico 03) durante el periodo 2024–SE 25 del 2026 evidencia una ocurrencia esporádica de casos, sin agregación temporal ni incremento sostenido de la notificación entre semanas epidemiológicas. En 2024 se registró un único caso en la SE 34, mientras que en 2025 la notificación se concentró en la SE 1; en contraste, durante el periodo evaluado del año 2026 no se notificaron casos. La ausencia de casos consecutivos y de conglomerados temporales no sugiere la presencia de cadenas de transmisión activa o brotes dentro de la jurisdicción. En conjunto, la serie temporal refleja un comportamiento de baja endemicidad, caracterizado por eventos aislados y sin evidencia de cambios relevantes en el patrón epidemiológico de la enfermedad.

Gráfico 03. Microred Yerbabuena: Comportamiento temporal de los casos de varicela según semana epidemiológica, 2024–SE 25, 2026.



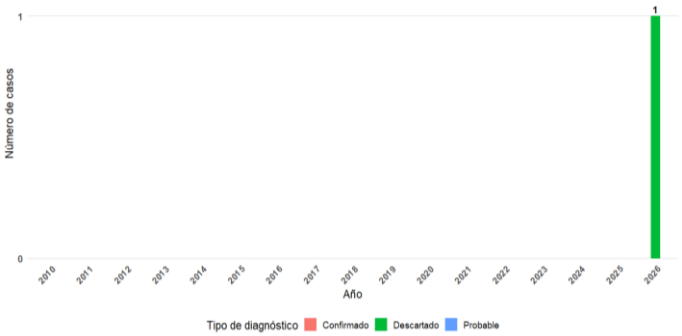
Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

Situación epidemiológica de Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral aguda altamente contagiosa causada por el virus del sarampión (género *Morbillivirus*, familia *Paramyxoviridae*), cuya transmisión ocurre principalmente por vía aérea mediante aerosoles y secreciones respiratorias. Se caracteriza por un elevado potencial de transmisión, con un número básico de reproducción (R_0) estimado entre 12 y 18, uno de los más altos entre las enfermedades infecciosas. Aunque la vacunación ha reducido significativamente su incidencia a nivel mundial, la persistencia de brechas en las coberturas de inmunización y la importación de casos continúan favoreciendo la ocurrencia de brotes, incluso en países que habían logrado interrumpir la transmisión endémica [8,9].

En el Perú, el sarampión es un evento sujeto a vigilancia epidemiológica intensificada, debido al riesgo permanente de reintroducción del virus asociado a los desplazamientos poblacionales y a la disminución de las coberturas de vacunación observadas en diversos países. En este contexto, la detección oportuna de todo caso sospechoso de enfermedad febril eruptiva, la investigación epidemiológica inmediata, la confirmación laboratorial y la respuesta rápida constituyen componentes esenciales para mantener la eliminación del sarampión y prevenir el restablecimiento de la transmisión endémica [10].

Gráfico 04. Microred Yerbabuena: Tendencia anual de casos de Sarampión, según tipo de diagnóstico, 2010 – 2026*



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

Durante el periodo 2010–SE 25 del 2026 no se notificaron casos confirmados ni probables de sarampión en la Microred de Salud Yerbabuena. El único evento registrado correspondió a un caso descartado en el año 2026, sin evidencia de incremento en la notificación de casos sospechosos respecto a los años previos. En conjunto, la serie histórica muestra la ausencia de casos confirmados durante el periodo evaluado, comportamiento compatible con el mantenimiento de la eliminación del sarampión en la jurisdicción y con la ausencia de transmisión autóctona.

La investigación epidemiológica del caso sospechoso de sarampión evidenció una respuesta oportuna e integral del sistema de vigilancia, iniciándose inmediatamente las acciones de notificación, investigación de campo y confirmación laboratorial. Como parte de la respuesta se realizó búsqueda activa comunitaria en 436 viviendas, búsqueda activa institucional mediante la revisión de 1 366 atenciones y seguimiento completo al 100 % de los contactos identificados, sin detectarse casos secundarios ni evidencia de transmisión comunitaria. El resultado negativo por RT-PCR permitió clasificar el evento como caso descartado, descartándose la circulación del virus del sarampión en la jurisdicción durante el periodo evaluado.

Tabla 04. Microred Yerbabuena: Resumen de la investigación epidemiológica del caso sospechoso de sarampión, SE 21 – 25, 2026.

VARIABLE	CASOS
CASOS INVESTIGADOS	
Casos sospechosos investigados	1
Casos confirmados	0
Casos probables	0
Casos descartados	1
LABORATORIO	
Resultado RT-PCR para virus sarampión	1
Negativo	1
Positivo	0
INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	
Contactos identificados	2
Contactos con seguimiento completo	2
Casos secundarios identificados	0
BÚSQUEDA ACTIVA Y RESPUESTA	
Viviendas visitadas (Búsqueda Activa Comunitaria)	436
Diagnósticos revisados (Búsqueda Activa Institucional)	1 366
Brigadas desplegadas	5
Monitoreo rápido de coberturas	1
Bloqueo vacunal realizado	1
RESULTADO FINAL	
Clasificación del evento	1
Caso descartado	**1**
TOTAL	**1**

Fuente: Informe de investigación epidemiológica de enfermedad febril eruptiva. Microred de Salud Yerbabuena, SE 25-2026.

La respuesta desarrollada frente al caso sospechoso permitió verificar el adecuado funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad febril eruptiva en la Microred de Salud Yerbabuena, garantizando la detección, investigación, confirmación laboratorial y clasificación oportuna del evento. El descarte del caso, la ausencia de transmisión secundaria y la ejecución de las actividades de control establecidas permitieron concluir que no existió evidencia de circulación del virus del sarampión en la jurisdicción durante el periodo evaluado, manteniéndose el escenario epidemiológico compatible con la condición de eliminación de esta enfermedad en el país.

Situación epidemiológica de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)

Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) constituyen una de las principales causas de morbilidad en la población infantil y representan un importante problema de salud pública, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Su presentación está estrechamente relacionada con deficiencias en el acceso a agua segura, saneamiento básico e higiene, así como con factores ambientales y socioeconómicos que favorecen la transmisión de agentes infecciosos. Aunque la mayoría de los episodios son autolimitados, las EDA continúan siendo una causa importante de deshidratación, hospitalización y mortalidad en menores de cinco años [11].

En el Perú, las EDA forman parte de los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica mediante notificación semanal, lo que permite monitorear su comportamiento temporal, detectar incrementos inusuales, identificar grupos de mayor riesgo y orientar oportunamente las intervenciones de prevención y control. El análisis continuo de esta información constituye una herramienta fundamental para evaluar la situación epidemiológica y fortalecer la toma de decisiones en los diferentes niveles del sistema de salud [12].

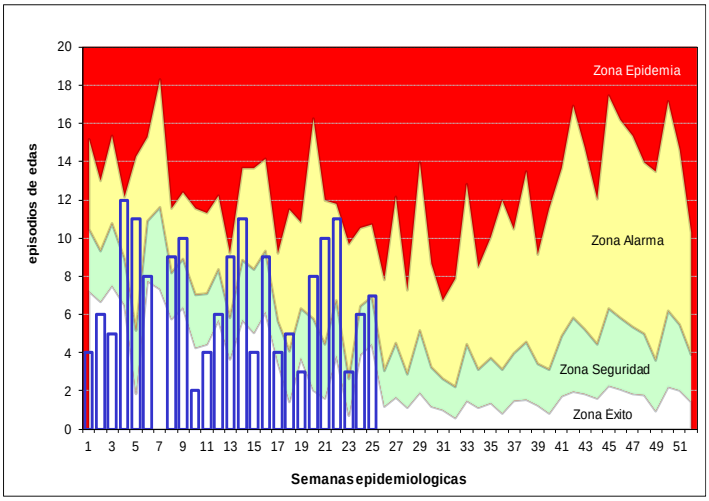
Tabla 05. Microred Yerbabuena: Casos acumulados por establecimientos y grupo etario, 2022 – 2026*

ESTABLECIMIENTO	Niño [0-11]	Adolescente [12-17]	Joven [18-29]	Adulto [30-59]	Adulto mayor [60+]	Total
C.S. YERBABUENA	16	11	7	28	13	75
C.S. LA JALCA GRANDE	8	1	3	4	1	17
P.S. EL PUENTE	3	1	2	1	0	7
P.S. DURAZNOPAMPA	2	1	0	2	1	6
P.S. QUILLUNYA	0	0	1	0	0	1
P.S. QUELUCA	0	0	0	0	1	1
P.S. BUIQUIL	0	0	0	1	0	1
P.S. PENGOTE	1	0	0	0	0	1
P.S. EL MANGO	0	0	0	1	0	1
P.S. CUEYQUETA	0	0	0	0	0	0
P.S. TACTA	0	0	0	0	0	0
P.S. MONTEVIDEO	0	0	0	0	0	0
P.S. LOPECANCHA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	30	14	13	37	16	110

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25, de todos los años.

Entre los años 2022 al 2026, con fecha de corte a la S.E.25 se notificaron 110 casos de enfermedad diarreica aguda (EDA) en la Microred de Salud Yerbabuena. La mayor carga de enfermedad se concentró en los grupos de adultos de 30 a 59 años (33,6 %) y niños de 0 a 11 años (27,3 %), que en conjunto representaron más del 60 % de los casos acumulados. Asimismo, el C.S. Yerbabuena notificó el mayor número de episodios (68,2 %), seguido del C.S. La Jalca Grande (15,5 %), concentrando entre ambos más del 80 % de las notificaciones registradas durante el periodo evaluado. Este comportamiento refleja una distribución heterogénea de la carga de enfermedad entre establecimientos y grupos etarios dentro de la jurisdicción.

Gráfico 05. Microred Yerbabuena: Canal endémico de EDA acuosa por SE, 2026*



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

El canal endémico de enfermedad diarreica aguda (EDA) para el año 2026 evidencia que, durante las primeras semanas epidemiológicas, la notificación de casos se mantuvo principalmente dentro de las zonas de seguridad y alarma, registrándose incrementos puntuales que superaron el umbral esperado sin alcanzar de manera sostenida la zona de epidemia. En conjunto, el comportamiento observado no evidencia un incremento epidémico sostenido de EDA en la Microred Yerbabuena durante el periodo evaluado, aunque se identificaron fluctuaciones semanales compatibles con la variabilidad habitual del evento.

Situación Epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Neumonías, SOB/ASMA

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen uno de los eventos de mayor importancia en la vigilancia epidemiológica debido a su elevada frecuencia, impacto en la morbilidad y potencial para ocasionar complicaciones como neumonía, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Su comportamiento está influenciado por factores estacionales, condiciones climáticas, contaminación ambiental,

hacinamiento y circulación de virus y bacterias respiratorias, por lo que el monitoreo continuo resulta fundamental para identificar oportunamente cambios en su tendencia epidemiológica [13].

En el Perú, las IRA, neumonías y el síndrome obstructivo bronquial/asma (SOB/ASMA) forman parte de la vigilancia epidemiológica rutinaria mediante notificación semanal, permitiendo evaluar su comportamiento temporal, detectar incrementos inusuales y orientar las intervenciones de prevención y control. El análisis sistemático de estos eventos facilita la identificación de grupos de mayor riesgo, la evaluación del impacto de las medidas de salud pública y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud frente a enfermedades respiratorias de importancia epidemiológica [14].

Tabla 06. Microred Yerbabuena: Episodios y razón por IRA, 2021 - 2026*.

Años	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Episodios	201	122	391	356	347	336
TIA x 10 Mil Hab.	4950.74	4121.62	9444.44	8000.00	7430.41	9180.33

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

Entre los años 2021 y la S.E. 25 del 2026 se observa una variabilidad en la ocurrencia de episodios de infección respiratoria aguda (IRA) en la Microred de Salud Yerbabuena. El mayor número de episodios e incidencia acumulada se registró en el año 2023 (391 episodios; TIA: 9 444,44 por 10 000 habitantes), seguido del año 2026 (336 episodios; TIA: 9 180,33 por 10 000 habitantes). En comparación con el mismo periodo del año 2025, durante el 2026 se evidencia un incremento de la tasa de incidencia, pese a registrarse un menor número absoluto de episodios, comportamiento influenciado por la variación del denominador poblacional. En conjunto, la carga de enfermedad por IRA se mantiene elevada durante los últimos cuatro años, consolidándose como uno de los principales eventos sujetos a vigilancia epidemiológica en la jurisdicción.

En la tabla 07, durante el periodo 2022–SE 25 del 2026 se notificaron 1 726 episodios de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de cinco años, observándose una marcada concentración en el grupo de 1 a 4 años, que representó el 76,8 % del total de episodios, seguido de los niños de 2 a 11 meses (21,1 %). En contraste, los menores de 2 meses aportaron únicamente el 2,1 % de los casos. La distribución etaria evidencia que la mayor carga de enfermedad se concentra en la población preescolar, patrón consistente con la mayor susceptibilidad y frecuencia de exposición descrita para este grupo durante la primera infancia.

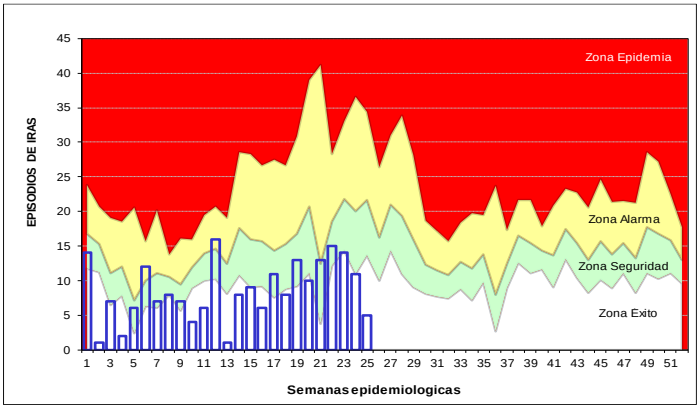
Tabla 07. Microred Yerbabuena: Casos acumulados de IRAS por grupo etario, 2022 – 2026*

Grupo etario	Casos	%	% acumulado
<2 meses	36	2.09	2.09
2-11 meses	364	21.09	23.18
1-4 años	1,326	76.83	100.01
5-9 años	0	0.00	100.01
10-19 años	0	0.00	100.01
20-59 años	0	0.00	100.01
60 años y más	0	0.00	100.01

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

El canal endémico de episodios de IRA en menores de cinco años muestra que, durante las semanas epidemiológicas evaluadas (SE 1–25), la notificación presentó fluctuaciones dentro del comportamiento esperado para el evento. Si bien se registraron incrementos progresivos entre las SE 18 y 24, los episodios se mantuvieron predominantemente entre las zonas de seguridad y alarma, sin superar de manera sostenida el umbral epidémico. Este comportamiento es compatible con la estacionalidad habitual de las infecciones respiratorias agudas y no evidencia un exceso de casos que sugiera un comportamiento epidémico durante el periodo analizado.

Gráfico 06. Microred Yerbabuena: Canal endémico de episodios de IRA en menores de 5 años. año 2026*



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 25-2026.

Indicador de monitoreo de la notificación del sistema de vigilancia epidemiológica

Los indicadores de monitoreo contribuyen a mejorar la información semanal para que esta sea oportuna y de calidad; consecuentemente la Microred de Yerbabuena pueda cumplir con el procesamiento y análisis de datos válidos para la toma de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia en salud pública. Teniendo como criterios de calificación para los Indicadores de Monitoreo: **DEBIL, REGULAR, BUENO Y OPTIMO.**

Estratos Nacionales

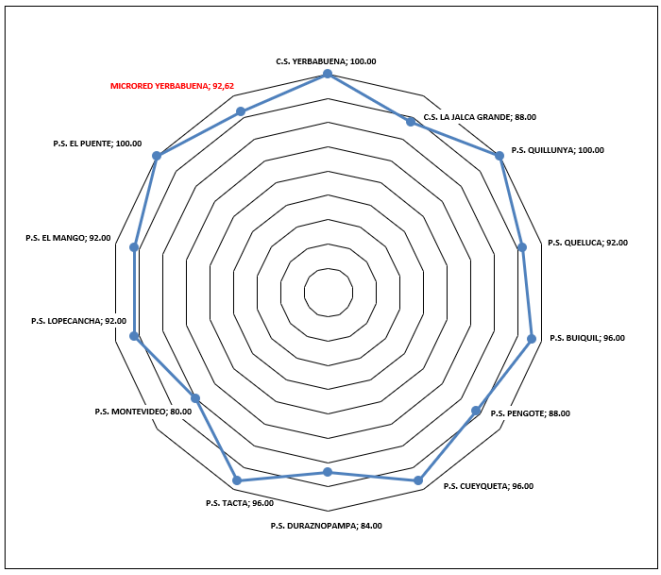
OPORTUNIDAD %	COBERTURA %	CALIDAD DEL DATO %	RETROALIMENTACION %	PUNJTAJE TOTAL
1. 100	1. 100	1. 95 - 100	1. 90 - 100	**A.** 90 - 100 **OPTIMO**
2. 95 - 99.9	2. 80 - 99.9	2. 90 - 94.9	2. 80 - 89.9	**B.** 80 - 89.9 **BUENO**
3. 90 - 94.9	3. 60 - 79.9	3. 85 - 89.9	3. 70 - 79.9	**C.** 70 - 79.9 **REGULAR**
4. <90	4. <60	4. <85	4. <70	**D.** <70 **DEBIL**

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades - MINSA

Indicador de Oportunidad

En los indicadores de oportunidad, a la semana epidemiológica (25) del año 2026, los establecimientos del C.S. Jalca Grande (88%), P.S. Pengote (88%), P.S. Duraznopampa (84%) y el P.S. Montevideo (80%) obtuvieron una calificación de oportunidad **BUENA.** Por otro lado, los demás establecimientos de la jurisdicción de la Microred Yerbabuena calificaron como **ÓPTIMA.**

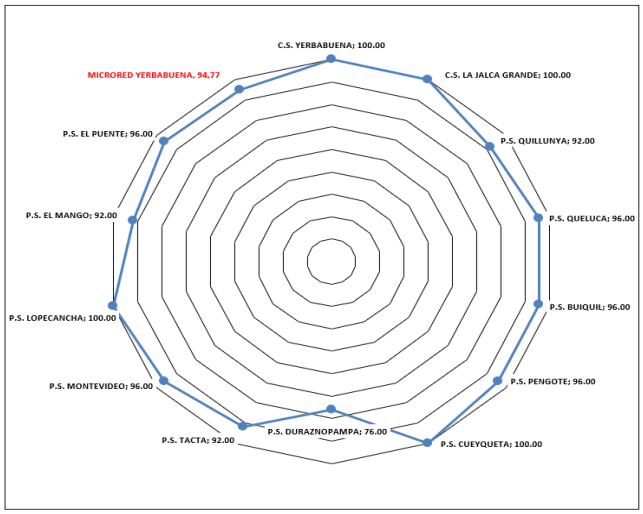
Gráfico 07. Microred Yerbabuena: Oportunidad de notificación del año 2026*



Fuente: Equipo técnico de Epidemiología Microred Yerbabuena, *Hasta la SE 25.

Por lo tanto, a nivel de la Microred Yerbabuena se alcanzó un puntaje de **92.62%** calificando como **OPTIMO.**

Gráfico 08. Microred Yerbabuena: Calidad de notificación del año 2026*



Fuente: Equipo técnico de Epidemiología Microred Yerbabuena, *Hasta la SE 25.

En el indicador de calidad de datos, hasta las SE 25 del año 2026, se observa que el P.S. Duraznopampa (76%) presenta una calificación **REGULAR**, a diferencia de los demás establecimientos que califican dentro de los parámetros de **OPTIMO.**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Leishmaniasis [Internet]. [citado el 3 de julio de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis?utm_source=
2. Manual of procedures for leishmaniases surveillance and control in the Americas. (2019). [Publications]. PAHO. https://iris.paho.org/handle/10665.2/51838
3. Organización Panamericana de la Salud. Leishmaniasis: Epidemiological Report for the Americas. No. 13. December 2024
4. World Health Organization. Varicella and herpes zoster (chickenpox and shingles). Geneva: WHO; 2024. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/varicella-and-herpes-zoster
5. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Overview of Varicella. Atlanta: CDC; actualizado 2024. Disponible en: https://www.cdc.gov/chickenpox/hcp/clinical-overview/index.html
6. Marin M, et al. Prevention of Varicella: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep.* 2007;56(RR-4):1-40. (Continúa siendo la guía de referencia internacional sobre epidemiología y prevención). Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5604a1.htm
7. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación (vigente). Disponible en: https://www.gob.pe/minsa
8. Sarampión [Internet]. Quien.int. [citado el 4 de julio de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles?utm_source=
9. Centro para el control y prevención de enfermedades. Panorama clínico del sarampión [Internet]. Sarampión (Rubéola). 2026 [citado el 4 de julio de 2026]. Disponible en: https://www.cdc.gov/measles/hcp/clinical-overview/index.html?utm_source=
10. Minsa. Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de sarampión, rubeóla y otras enfermedades febriles eruptivas. [Internet]. Disponible en:

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/directiva-sanitaria-de-sr.pdf
11. Diarrhoeal disease [Internet]. Who.int. [citado el 4 de julio de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease?utm_source=
12. Minsa. Norma Técnica de salud para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en el Perú [Internet]. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/eda/NTS_190-2022-MINSA-CDC-EDA.pdf
13. Minsa. Infecciones respiratorias agudas en el Perú. [Internet]. Disponible en: https://iris.paho.org/server/api/core/bitstreams/1c80b975-35eb-4b79-b64a-0654b10571af/content
14. Minsa. Directiva Sanitaria N°061 para la vigilancia epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas, 2015. [Internet]. Disponible en: https://riscuscovraem.pe/wp-content/uploads/2024/07/Directiva-vigilancia-IRA.pdf